

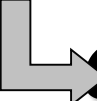
# *CANCERS DU FOIE*

# ***CANCERS DU FOIE***

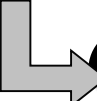
## ***Définition***

*Ensemble des proliférations malignes se développant :*

*-Soit au dépend d'un des constituants histologiques normaux du foie( hépatocytes, C biliaire,vaisseaux.)*

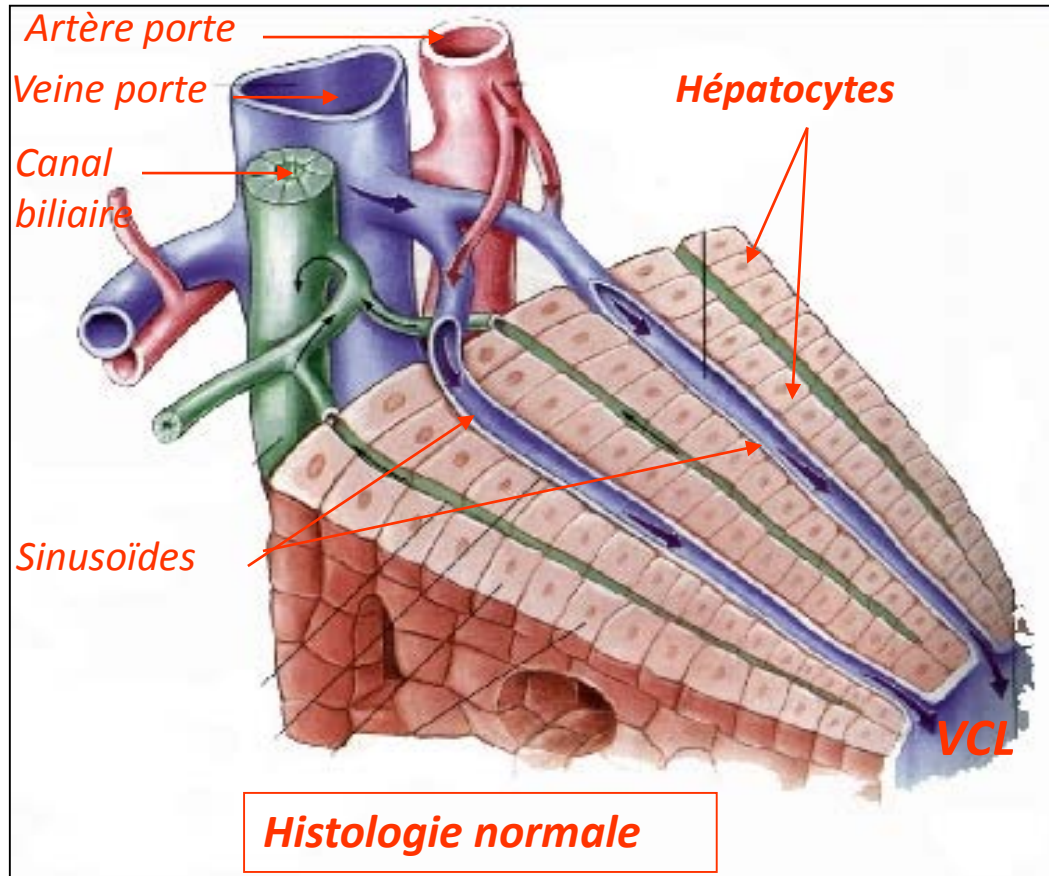
 ***Cancers primitifs***

*-Soit à partir d'un cancer à distance (extrahépatiques)*

 ***Cancers secondaires (métastases)***

- Tumeur maligne primitive du foie
  - Carcinome hépatocellulaire CHC
  - Cholangiocarcinome
  - Angiosarcome
- Tumeur maligne secondaire du foie
- Tumeur bénigne primitive du foie
  - Adénome hépatique
  - Angiome hépatique

# Origine tissulaire du cancer primitif du foie



Structures hépatocytaires

Carcinome hépatocellulaire  
=  
hépatocarcinome

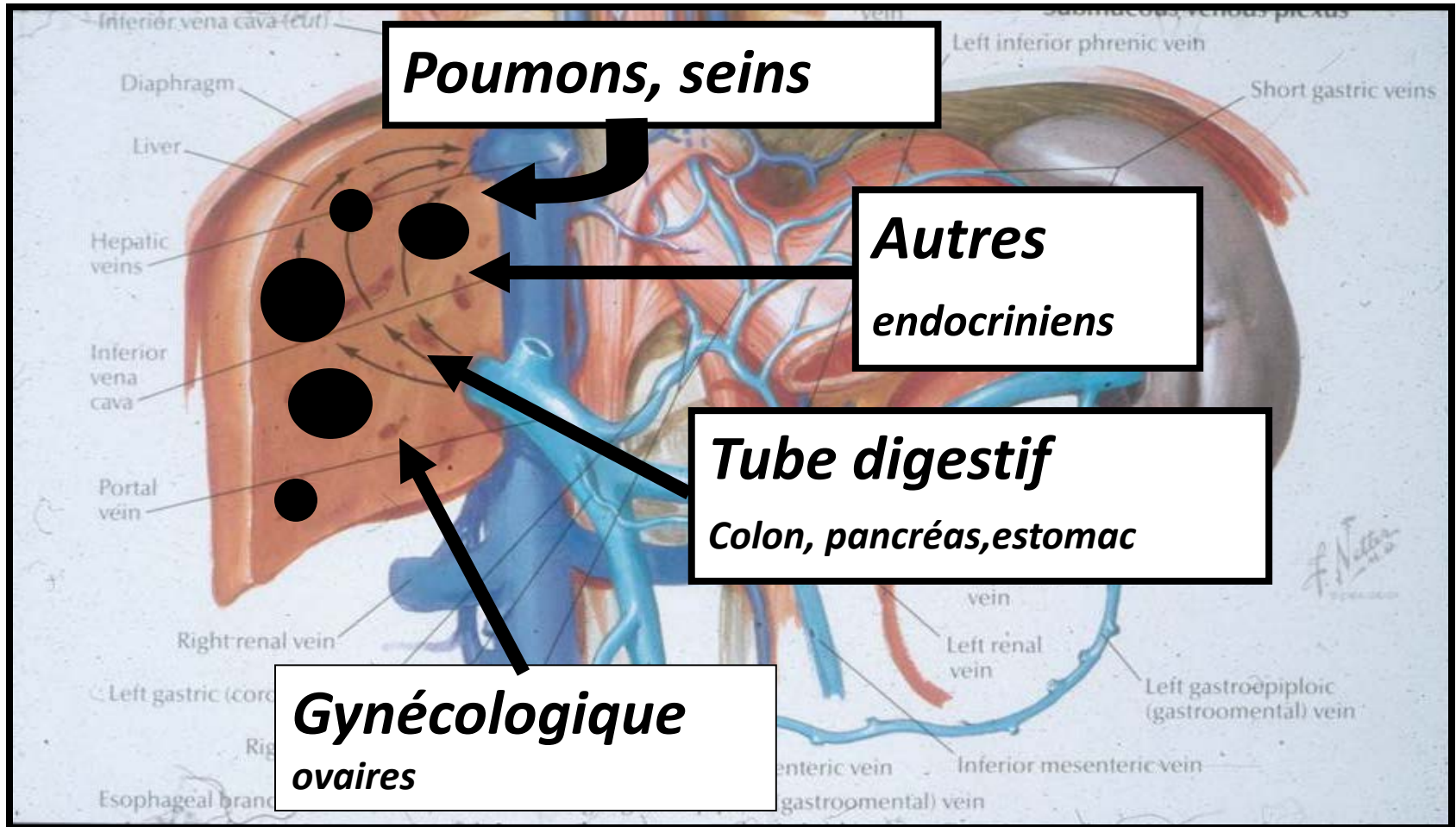
Structures biliaires

cholangiocarcinome

Structures vasculaires

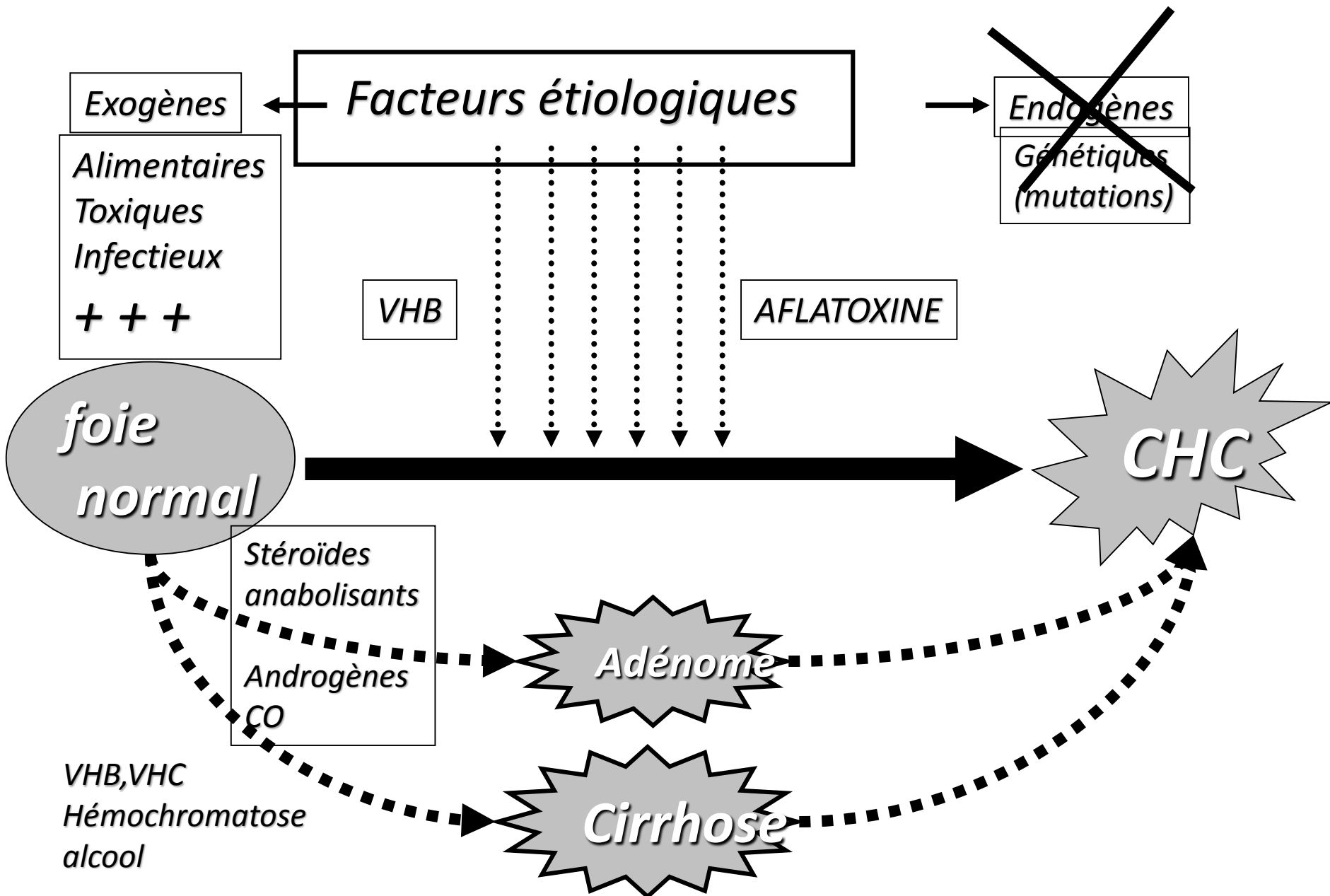
hémangiosarcome

# *Origine tissulaire du cancer secondaire du foie*



***ETIOPATHOGENIE***

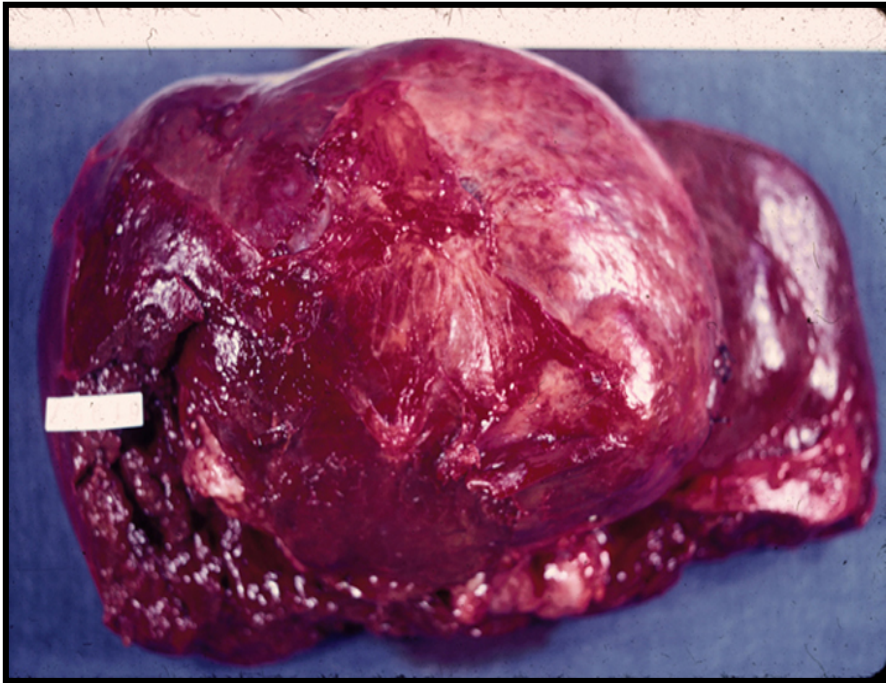
# *Carcinogénèse du CHC*



# ***ANATOMO-PATHOLOGIE***

# *ANATOMIE PATHOLOGIQUE*

## Macroscopie



*Multinodulaire*  
*1 ou 2 masses principales*  
*+*  
*nodules satellites*



*Nodules polychromes*  
*(verts, blancs ou rouges)*  
*+*  
*Friables*

# ANATOMIE PATHOLOGIQUE

## Microscopie

### 1 Architecture

*Bien différencié → trabéculaire  
Modérément différencié → cordons, alvéoles  
Peu différencié → nappes*

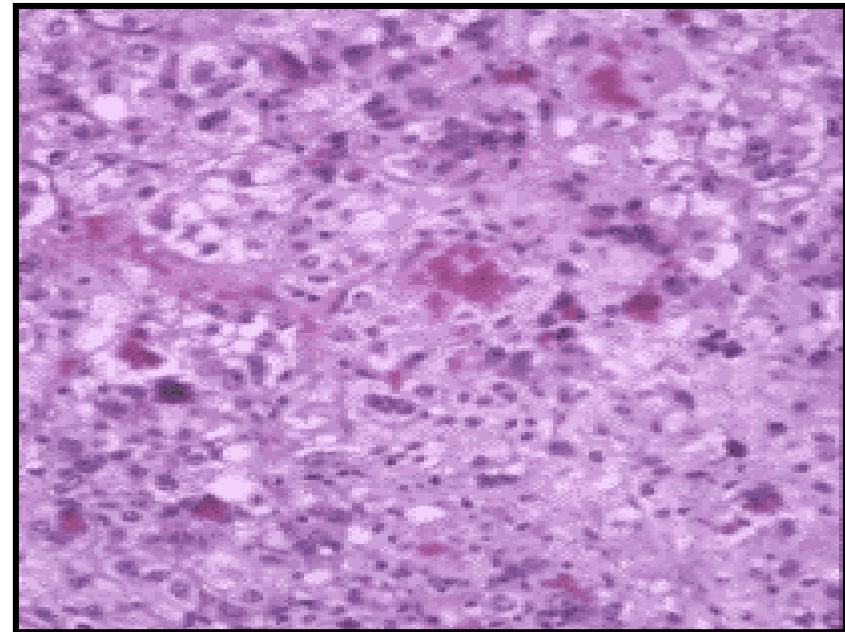
### 2 Cellules

*Polygonales, éosinophiles  
pouvant contenir bile, glycogène, lipides*

### 3 Stroma

*très vasculaire*

### CHC moyennement différencié



### 4 marqueurs tissulaires

*Alpha foeto protéine  
(positive dans 50 % des cas environ)*

# ANATOMIE PATHOLOGIQUE

*Extension tumorale*

*Voies de dissémination*

*Contiguïté*

*Vasculaire*

*Lymphatique*

*Extension intrahépatique*

*Extension régionale*

*1. Métastases hépatiques*

*2. Compression et envahissement  
des structures vasculaires et biliaires*

*1. Thrombose porte.*

*++++*

*2. Adénopathies régionales:  
Hile, coelimésentériques*

*Extension à distance*

*1. Poumons*

*2. Adénopathies*

# *MANIFESTATIONS CLINIQUES*

# *MANIFESTATIONS CLINIQUES*

*Deux grandes situations*

```
graph TD; A[Deux grandes situations] --> B[CHC sur foie de cirrhose<br/>(Cirrhose connue ou non)]; A --> C[CHC sur foie sain];
```

*CHC*  
*sur foie de cirrhose*

*(Cirrhose connue ou non)*

*CHC*  
*sur foie sain*

# *CHC sur foie de cirrhose*

## **1** *Stade précoce*

- *Diagnostic petit CHC est un objectif PEC cirrhotique.*
- *Ceci possible → dépistage systématique.*

*Echo hépatique +  $\alpha$ FP / 6 mois*

- *signes cliniques de l'hépatopathie sont au 1<sup>er</sup> plan*

# *CHC sur foie de cirrhose*

2

## *Stades tardifs*

- *Modification du tableau clinique :*
  - 1-*Altération état général ( amaigrissement)*
  - 2-*Fièvre inexpliquée*
  - 3-*Augmentation du volume du foie*
  - 4-*Douleurs hypochondre droit*
  - 5-*Ascite hémorragique ou chyleuse*
- *Pas de traitement curatif .*

# *CHC sur foie de cirrhose*

3

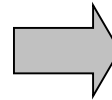
## *Autre situation*

- *Parfois la cirrhose n'est pas connue.*
- *Le CHC révèle la maladie hépatique*
- *Tableau clinique associe :*
  - *Signes d'hépatopathie chronique*
  - *Foie tumoral*
- *Diagnostic souvent tardif*

## 5 Tableaux cliniques

1) F. tumorale: fréquente

hépatomégalie tumorale



- **Visible**
- **Palpable**
- **Evolutive**

2) F. fébrile: tableau d'abcès hépatique (nécrose tumorale)

3) F. douloureuse: douleurs intenses hypochondre droit

Hémorragie sous capsulaire → rupture → hémopéritoine → décès

4) F. ictérique: ictère franc domine le tableau clinique

Tumeur infiltrant tout le foie OU envahissement /compression VBP

5) F. asymptomatique: découverte fortuite, Tumeur petite taille

# *EXAMENS COMPLEMENTAIRES*

## *Biologie*

### 1. Exploration fonctionnelle hépatique:

- Fonction hépatique : → IHCaire ( Cirrhose / Tumeur étendue )  
→ conservée ( Petit CHC sur foie sain )
- Syndrome de cholestase : → PA et GGT

### 2. Marqueurs tumoraux :     *Alphafoetoprotéine( $\alpha$ FP)*

- Protéine foétale, état de trace chez l'adulte, élevée au cours CHC

*Seuil significatif > 500ng/ml*

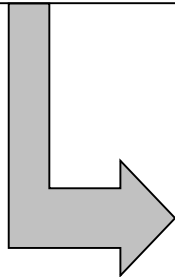
- Remarque: Normale : Petit CHC. Augmentée: Hépatite aigue, Grossesse

### 3. Syndrome paranéoplasique: *Polyglobulie, hypercalcémie, hypoglycémie*

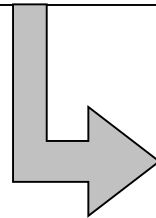
# ***EXAMENS COMPLEMENTAIRES***

***Imagerie → 3 Examens***

***ECHOGRAPHIE  
ABDOMINALE***



***TOMODENSITOMETRIE  
ABDOMINALE  
(SCANNER)***



***IRM ABDOMINALE***

# IMAGERIE

## Echo abdominale

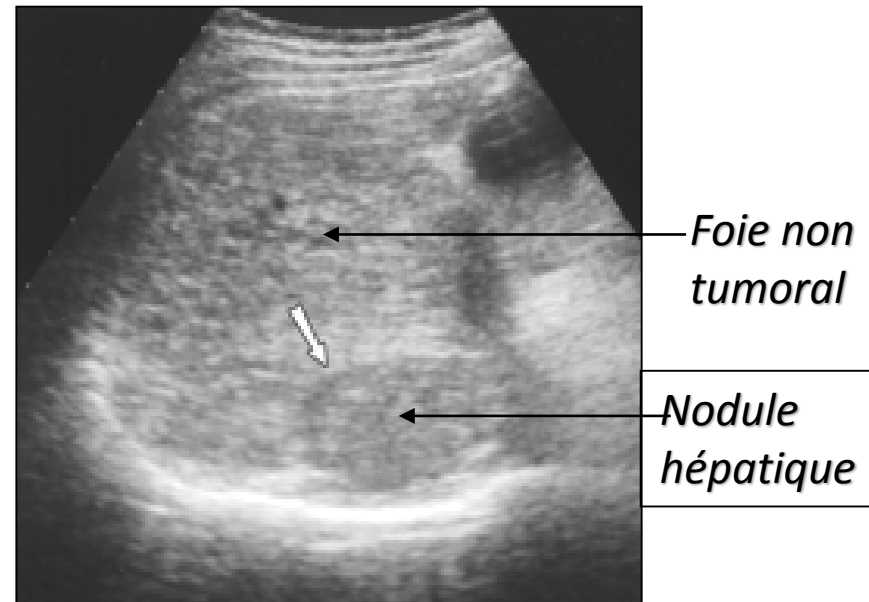
*simple, non invasif, peu coûteux, répétitif → 1ère intension dans le dépistage*

### A Renseigne sur la tumeur

1. Taille: Petite(<2cm), Grande(>5cm)
2. Echogénécité : Hypoéchogène
3. Siège: Variable
4. Nombre: Unique / multiple (n>3)

### B Renseigne sur son extension

1. Compression ou envahissement des structures de voisinage(Vx, biliaires)  
→ *thrombose porte* très évocatrice
2. Adénopathies profondes



### C Autres renseignements

Anomalies observées dans la cirrhose

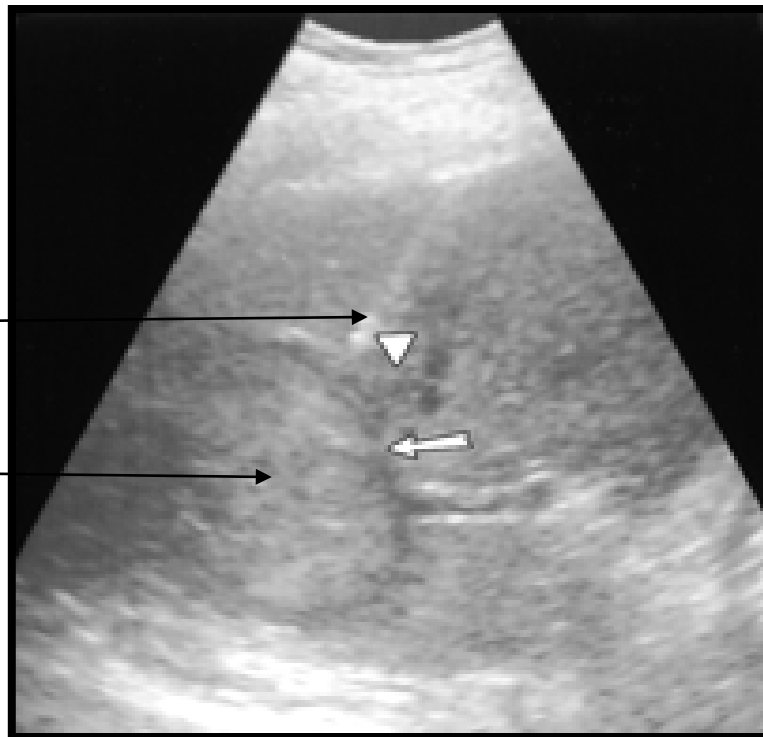
# *ECHOGRAPHIE HEPATIQUE*

*Autre intérêt → biopsie échoguidée*

*La biopsie n'est pas systématique*

*L'aiguille à biopsie*

*La tumeur*



# *TDM hépatique*

*Plus coûteux, injection produit contraste → 2<sup>ème</sup> intention*

*Conditions d'examen rigoureuses*

*matériel adéquat = scanner multibarrette*

*1<sup>er</sup> temps* : avant injection du produit de contraste (iodé)

*2<sup>ème</sup> temps* : après injection IV du produit de contraste

- *Coupes précoces* ( temps artériel)
- *Coupes tardives* (temps portal)

## *Principes radiologiques*

*La vascularisation hépatique est portale:*

*foie → Prise du contraste au stade tardif*

*La vascularisation du CHC est artérielle:*

*CHC → prise du contraste est précoce*

# *TDM hépatique*

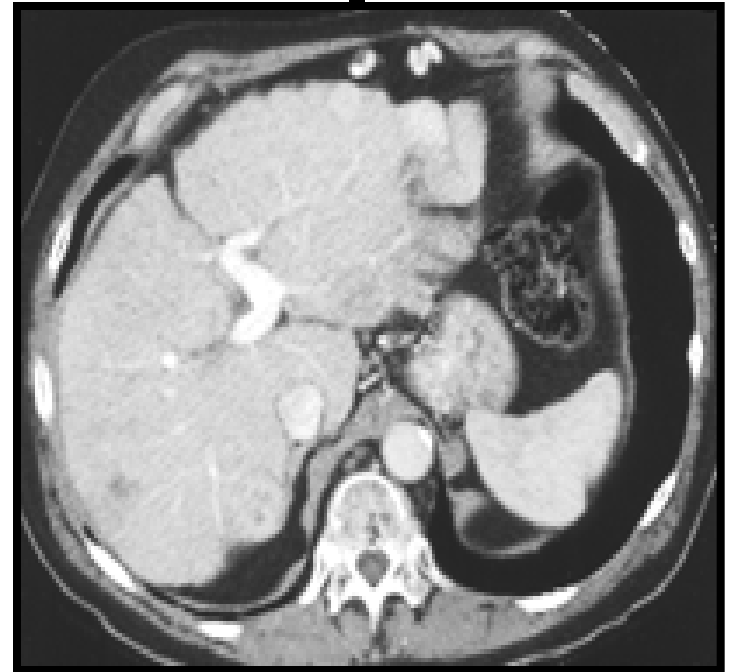
## *CHC multiple sur foie de cirrhose*

*Après injection du produit de contraste*

*Temps précoce (artériel)*



*Temps tardif (portal)*



*Une prise du PDC précoce avec nettoyage rapide*



*CHC  $\approx$  100%*

# *IRM hépatique*

*Très coûteux, n'est pas toujours disponible, très sensible → 3<sup>ème</sup> intention*

*Conditions d'examen rigoureuses*

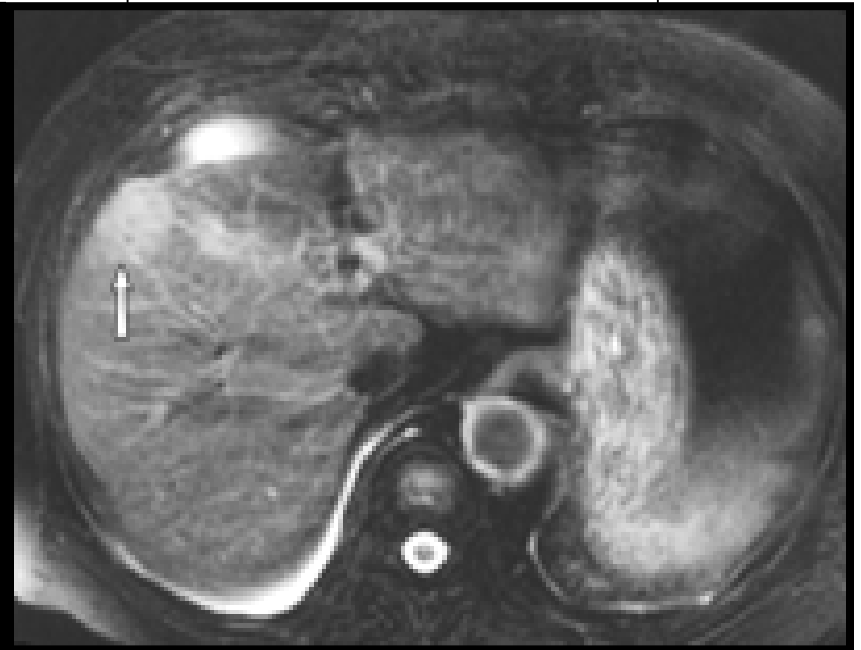
*PDC= gadolinium*

*Avant injection du PDC*



*Tumeur Hyposignal en T1*

*Après injection du PDC*



*Tumeur Hypersignal en T2*

*DIAGNOSTIC*

# Prise en charge générale du CHC

3 étapes

*Diagnostic précis*

*Positif*

*Différentiel*

2

*Bilan préthérapeutique*

*Extension tumorale*

*Foie non tumoral*

*État du malade*

3

*Curatif*

*Traitement*

*Palliatif*

# Comment poser le diagnostic d'un CHC ?

## 1 *Cas faciles*

*Cirrhose + nodule hépatique (critères morphologiques) +  $\alpha$ FP > 500 ng/ml*

*CHC  $\approx$  100%*

*La preuve histologique n'est pas nécessaire*

## 2 *Cas difficiles*

*cirrhose(-) / nodule atypique à l'imagerie /  $\alpha$ FP Nle*

*La preuve histologique est nécessaire*

*Biopsie hépatique  
échoguidée*

# *Il faudra éliminer ce qui n'est CHC*

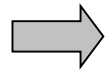
*Surtout dans les cas difficiles*

## 1. Ce qui n'est pas lésions tumorales

- *Pseudotumeurs*
- *Lésions kystiques*

## 2. Ce qui n'est pas tumeur maligne

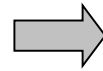
*Tumeurs bénignes*



*Angiome, adénome, hyperplasie nodulaire focale*

## 3. Ce qui n'est pas tumeurs malignes primitives

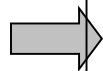
*Métastases = Cancers secondaires*



*Digestifs, gynécologiques, etc.*

## 4. Ce qui n'est pas hépatocarcinome

*Autres cancers primitives*



*Cholangiocarcinome, hémangiosarcome*

***TRAITEMENT***

## *Buts du traitement*

*3 buts*

*1. Traitement radical de la tumeur:*

*➔ Améliorer la survie*

*2. Traitement de l'hépatopathie à l'origine de la tumeur:*

*➔ Prévenir la récurrence tumorale*

*3. Traitement des symptômes:*

*➔ Améliorer la qualité de vie du malade*

# BILAN PRETHERAPEUTIQUE

*Clinique, biologique et morphologique*

1

*La tumeur*

*Nombre, taille, siège, extension locorégionale et générale*

2

*Etat du foie non tumoral*

*Score de Child en cas de cirrhose*

3

*Etat du malade*

*Opérabilité: âge, fonction respiratoire et cardiaque*

# *ARMES THERAPEUTIQUES*

*2 moyens de principes différents*

***TRAITEMENT  
CURATIF***

***TRAITEMENT  
PALLIATIF***

*Principe*

*Guérir le malade  
et  
améliorer sa survie*

*Améliorer la qualité de vie  
Sans  
augmenter la survie*

*1-Transplantation hépatique  
2-Exérèse chirurgicale*

*1-Alcoolisation=acétisation  
2-Radiofréquence  
3-Chimio-embolisation*

*Remarque*

*La radiothérapie et la chimiothérapie systémique n'ont pas de place dans le traitement du CHC*

# *Traitement palliatif*

## *Alcoolisation*

### *-Principe:*

*Injection intratumorale d'alcool absolu sous échographie → nécrose de coagulation*

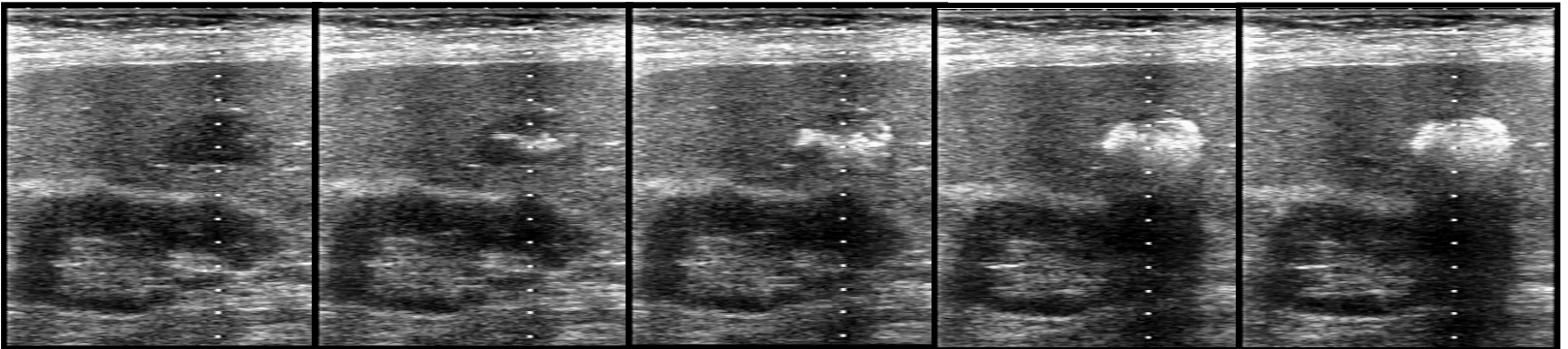
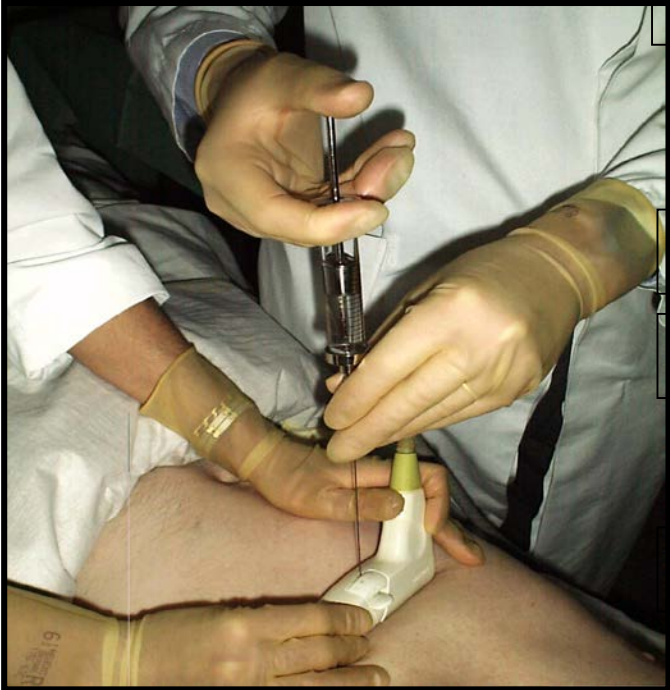
### *-Indication petit CHC 3cm*

### *- contre-indications*

*Troubles hémostase, CHC sous capsulaire*

### *-Complications*

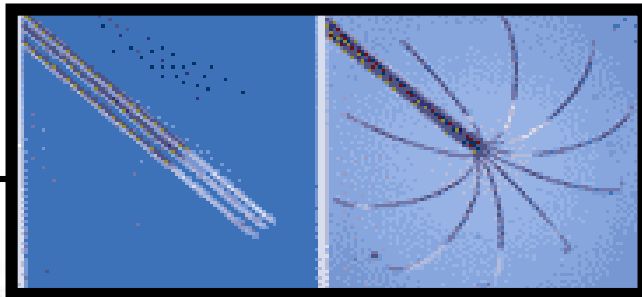
*Abcès, fièvre, Hgie.*



# Traitement palliatif

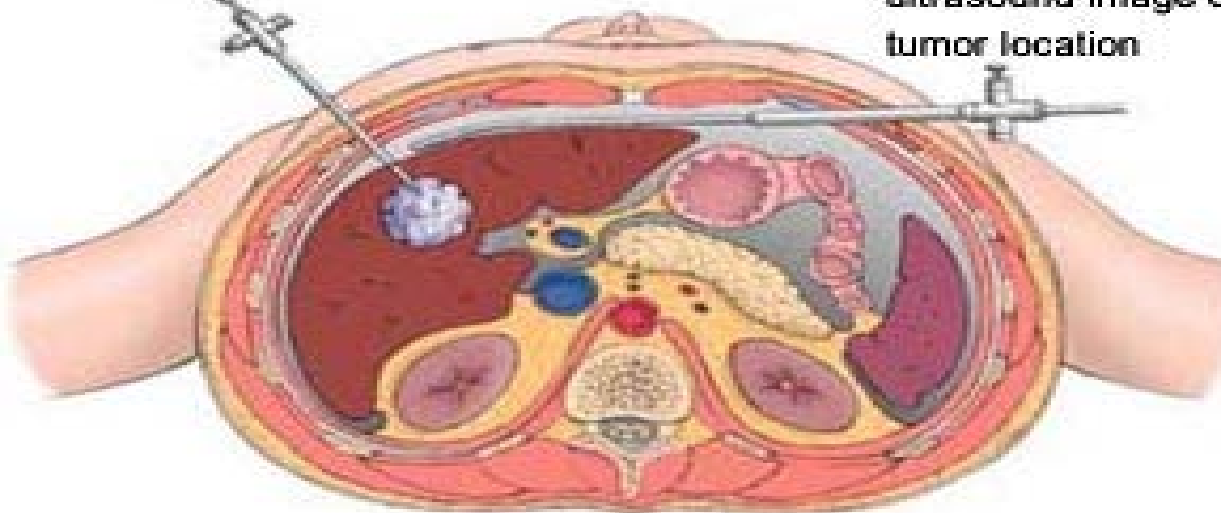
## Radiofréquence

*Destruction tumorale par un effet thermique*



RF probe

Laparoscope for  
ultrasound image of  
tumor location



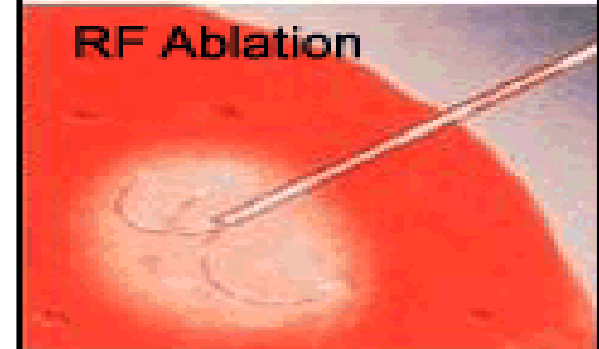
Introduction



Deployment

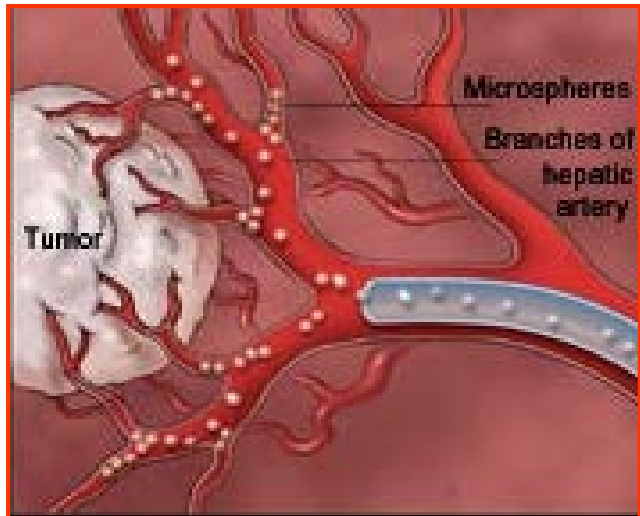
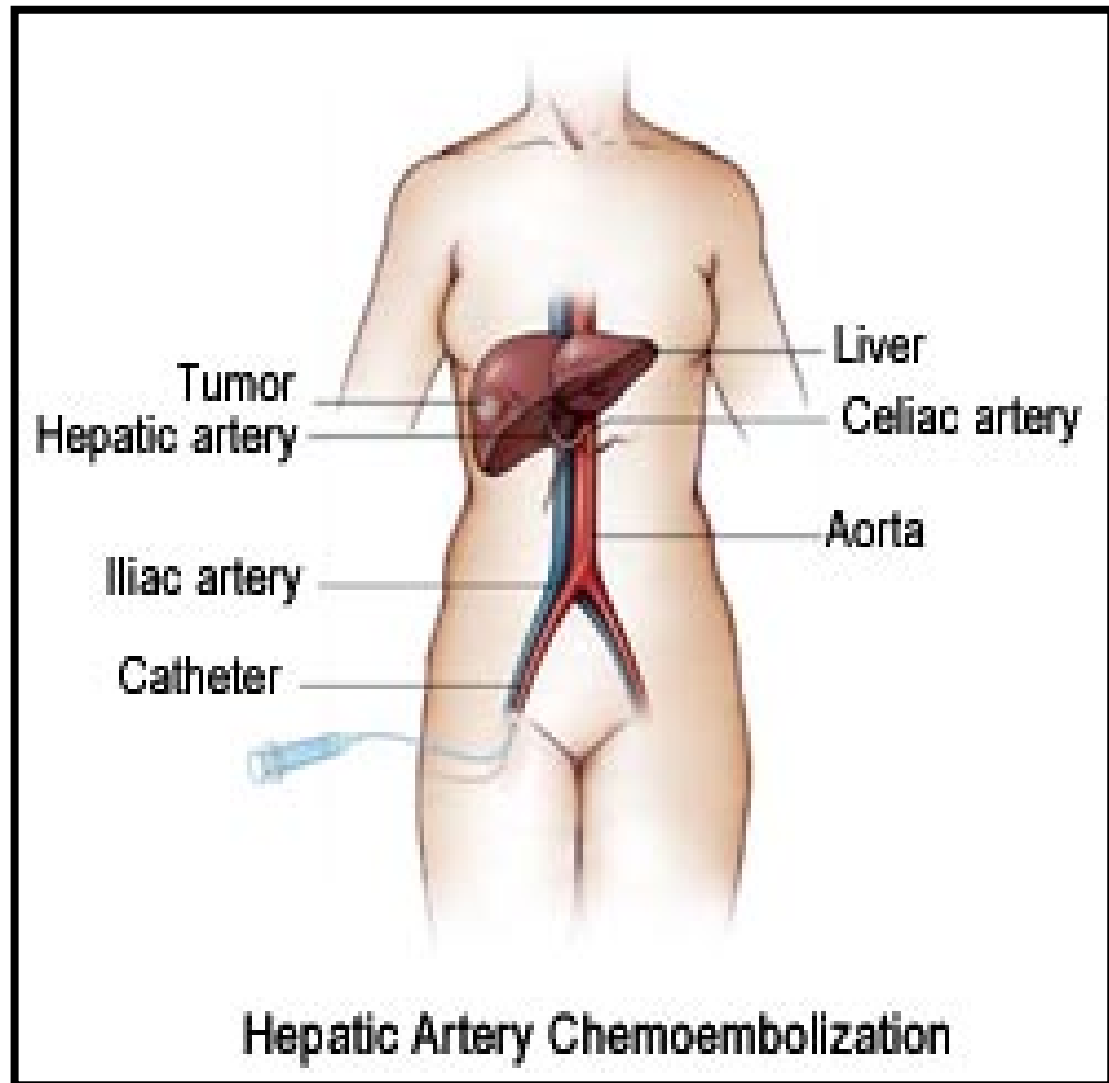
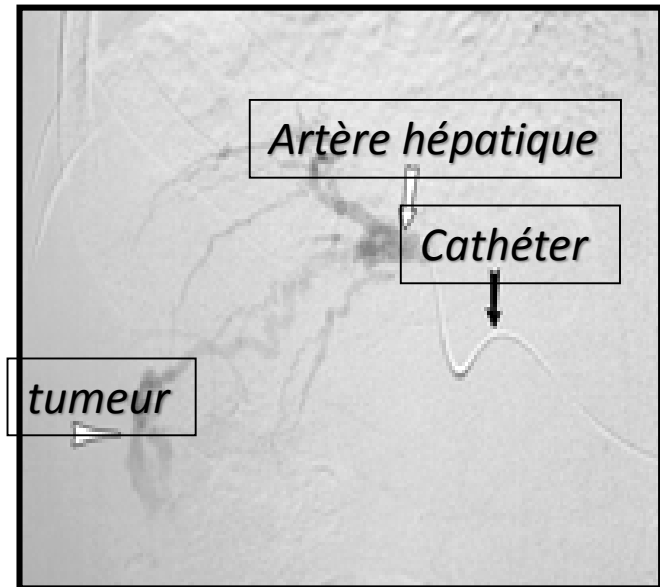


RF Ablation



# Traitement palliatif

## CHIMIOEMBOLISATION



# ***Traitement curatif***

*Résection chirurgicale*

*Geste chirurgical*

*RESECTION CARCINOLOGIQUE DE LA TUMEUR*

*Hépatectomie droite ou gauche*

*Inconvénients*

*On laisse en place le foie malade ➔ risque de récidence  
Risque d'insuffisance hépatocellulaire en post-opératoire*

*Indiquée*

*CHC sur foie sain , CHC sur cirrhose Child A en attente d'une TH*

# ***Traitement curatif***

*Transplantation hépatique*

*Constitue le meilleur traitement du CHC sur cirrhose*

*<10% de récidence à 3 ans*

*Indications bien précises*

*1 nodule <5 cm ou moins de 3 nodules <3cm sur cirrhose Child A*

*Technique chirurgicale*

*TH à donneur cadavérique mieux que le donneur vivant*

# INDICATIONS DU TRAITEMENT

*Bilan préthérapeutique*

*PETIT CHC*

- $T \leq 5\text{cm}$
- $N \leq 3$  et  $T \leq 3\text{cm}$
- Veine porte libre
- Métastases = non

*curatif*

TRASPLANTATION  
HEPATIQUE  
Ou RESECTION

*CHC ETENDU*

- $T > 5\text{cm}$  ou
- $N > 3$  et  $T > 3\text{cm}$
- thrombose porte
- Métastases = oui

*Palliatif*

- Chimio-embolisation
- Radiofréquence
- Alcoolisation

# *PREVENTION*

1

## *PREVENTION PRIMAIRE*

*Lutter contre les facteurs cancérigènes  
Vaccination contre VHB*

Exemple

*Taiwan  
vaccination VHB 1984*

*Prévalence Ag HBS  
10,7 % à 1,5 %  
1984 à 1989*

*incidence du CHC  
0.7 / 10<sup>5</sup> 81-86  
0.36 / 10<sup>5</sup> 90-94*

2

## *PREVENTION SECONDAIRE*

*Dépistage et traitement des malades infectés VHC ou VHB  
➔ État précancéreux = Cirrhose*

# *TUMEURS SECONDAIRES DU FOIE*

# *Cancers secondaires*

## *DEFINITION*

*Localisation hépatique de tumeur maligne primitive extra-hépatique.*

## *Origine des métastases*

*Tumeurs primitives essentiellement du tractus digestif (estomac, vésicule, pancréas, côlon ), sein, appareil génito-urinaire.*

# *Cancers secondaires*

## *Anatomo-pathologie*

### *Macroscopie*



*Presque toujours lésions multinodulaires ou infiltration diffuse plus rarement solitaire et massive nécrose centrale souvent caractéristique*

# *Manifestations cliniques*

## *Circonstances de découverte*

### *1 Tumeur primitive est connue*

*Les métastases hépatiques sont découverts soit dans le cadre:*

- Du bilan d'extension → Métastases synchrones.*
- De surveillance d'un cancer réséqué → Métastases métachrones*

*souvent asymptomatiques, découverte échographique*

### *2 Tumeur primitive n'est connue*

*Les métastases hépatiques révèle la maladie:*

*souvent symptomatique: Douleurs, Amaigrissement, HPM tumorale.*

# ***Examens complémentaires***

## ***Biologie***

*Syndrome de cholestase anictérique + + +  
PA, GGT*

## ***Morphologie: écho,TDM***

*Une ou plusieurs tumeurs intra-hépatiques; la partie centrale de la tumeur peut être nécrosée  
(image en cocarde)*

# *Traitement*

*Métastase hépatique n'est plus synonyme d'1 tumeur non curable*

*Traitement curatif possible*

*Repose sur le traitement d'abord de la tumeur primitive puis des métastases hépatiques souvent en deux temps associé souvent un traitement adjuvant ou néoadjuvant*

*Traitement souvent palliatif*

*Traitement      symptomatique*

# Adénome hépatique (tumeur bénigne)

- Rare
- Femme jeune
- Prise de contraceptifs oraux fortement dosés
- Asymptomatique
- TTT: arrêt des oestroprogestatifs et résection chirurgicale (si on pense qu'il y a un risque d'évolution vers un carcinome, ou complication de type hémorragique)